EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Elemento	Descripción
Código	01-05-2.0
Nombre	Porcentaje de embarazadas seropositivas para sífilis que reciben tratamiento oportuno y adecuado
Definición conceptual	Porcentaje de embarazadas seropositivas para sífilis que reciben atención en la consulta externa de primera vez a quienes se les brinda tratamiento oportuno y adecuado. • Embarazadas seropositivas para sífilis: mujeres desde el momento de la concepción hasta las 42 semanas de gestación con una prueba de laboratorio clínico de serología VDRL positiva o reactiva (independientemente de las titulaciones). • Tratamiento oportuno y adecuado: administración por vía intramuscular de 2,4 millones penicilina g benzatínica en los primeros 10 días hábiles a partir de la fecha de ingreso del reporte de la serología VDRL positivo, según sea el caso (Anexo 1). Incluye: • Consultas de primera vez en el embarazo (medicina general, enfermería, ginecología, medicina familiar): población de mujeres desde el momento de la concepción hasta las 42 semanas de gestación con FUR válida para el periodo. • Consultas de primera vez en el embarazo con diagnóstico presuntivo de sífilis (medicina general, enfermería, ginecología, medicina familiar): población de mujeres desde el momento de la concepción hasta las 42 semanas de gestación con FUR válida para el periodo. La FUR se considera válida cuando la diferencia entre la fecha de consulta de primera vez en el embarazo y la fecha de última regla (FUR) registrada en el apartado control prenatal ítem datos embarazo del expediente digital único en salud (EDUS) está entre una a 42 semanas. • Pruebas de laboratorio clínico: serología para VDRL reportada como positiva o reactiva (independientemente de las titulaciones) en el periodo, con una fecha de realización 10 días hábiles previos a la fecha de corte del periodo de evaluación. Excluye: • No aplica.
Variables involucradas en la medición	• Número de embarazadas seropositivas para sífilis que reciben tratamiento oportuno y adecuado en el periodo • Número de embarazadas seropositiva con FUR válida para el periodo

<table>
<tr><td>Fórmula de cálculo</td><td colspan="2">Número de embarazadas seropositivas para sífilis que reciben tratamiento oportuno y adecuado en el periodo
———————————————————— x 100
Número de embarazadas seropositiva con FUR válida para el periodo</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Desagregación</td><td>Nivel de atención</td><td>Primer Nivel</td></tr>
<tr><td>Componente de la prestación</td><td>Consulta externa</td></tr>
<tr><td>Componente de la atención integral</td><td>Prevención
Tratamiento (curación/mantenimiento)</td></tr>
<tr><td>Temática</td><td>Salud materno infantil</td></tr>
<tr><td>Línea base</td><td colspan="2">79 %</td></tr>
<tr><td>Meta</td><td colspan="2">Quinquenal: 100 %</td></tr>
<tr><td>Periodicidad</td><td colspan="2">Anual</td></tr>
<tr><td>Fuente de información</td><td colspan="2">Expediente Digital Único en Salud (Cubo DCSS EPSS Perinatal):
Consultas de primera vez en el embarazo por código CIE-10: Z321. Embarazo confirmado, Z33. Estado de embarazo incidental, Z34. Supervisión de embarazo normal, Z35. Supervisión de embarazo de alto riesgo, Z640. Problemas relacionados con embarazo no deseado, O300. Embarazo doble, O308. Otros embarazos múltiples y O309. Embarazo múltiple, no especificado.
Consultas de primera vez en el embarazo con diagnóstico presuntivo por sífilis por código CIE-10: A50 Sífilis congénita. A51 Sífilis precoz. A52 Sífilis tardía. A53 Otras sífilis y las no específicas. O981 Sífilis que complica el embarazo, parto y puerperio. R762 Falso positivo en la prueba serológica para sífilis. Z369 Pesquisa prenatal, sin otra especificación. Z224 Portador de agentes de enfermedades infecciosas con un modo de transmisión predominantemente sexual.
Consultas de primera vez de mujeres en el periodo posnatal por códigos CIE-10: Z390. Atención y examen inmediatamente después del parto, Z391. Atención y examen de madre en periodo de lactancia, Z392. Seguimiento postparto de rutina, Z370. Nacido vivo único, Z379. Producto de parto no específico, O800. Parto único espontáneo presentación cefálica de vértice, O03. Aborto espontaneo, O04. Aborto médico, O05. Otro aborto, O06. Aborto no especificado, O021 Aborto retenido y O60 Parto prematuro.
Sistema integrado de laboratorio clínico y LabCore®:
Pruebas de laboratorio clínico realizadas en el periodo: serología para VDRL.
Expediente Digital Único en Salud (Cubo DCSS EPSS Perinatal):
Pruebas de laboratorio clínico registradas en el énfasis correspondiente con fecha y resultado del periodo: serología para VDRL.</td></tr>
<tr><td>Clasificación</td><td colspan="2">Indicador de proceso</td></tr>
<tr><td>Presentación de resultados</td><td colspan="2">Reporte de resultados de la evaluación de la prestación de servicios de salud del primer nivel de atención (anual y monitoreo).
Informe de resultados de la evaluación de la prestación de servicios de salud del primer nivel de atención (anual).</td></tr>
</table>

Comentarios generales	No aplica

Anexo 1:
Tratamiento oportuno y adecuado para embarazadas seropositivas para sífilis

	Serología VDRL	Prueba Treponémica	Caso	Tratamiento adecuado	
Casos 1 y 2: CIE-10: Z369 Pesquisa prenatal, sin otra especificación	Positiva	Ausente	1	Aplicación de penicilina benzatínica G por vía intramuscular en las siguientes dosis, según corresponda:	Una dosis única de 2.4 millones de unidades de penicilina benzatínica G cuando hay presencia de síntomas o antecedentes recientes de signos o síntomas (menos de 1 año)
					Una dosis única de 2.4 millones de unidades de penicilina benzatínica G cuando la serología VDRL positiva corresponde a un control, muestra un aumento igual o mayor a 4 veces la titulación anterior y tiene antecedentes de signos o síntomas recientes
					Una dosis de 2.4 millones de unidades de penicilina benzatínica G por semana por tres semanas cuando no tiene síntomas o no recuerda historia de signos o síntomas
					Una dosis de 2.4 millones de unidades de penicilina benzatínica G por semana por tres semanas cuando la serología VDRL positiva corresponde a un control, muestra un aumento igual o mayor a 4 veces la titulación anterior y no tiene síntomas o no recuerda historia de signos o síntomas
			2	No aplicación de penicilina benzatínica G por vía intramuscular en los siguientes casos:	Cuando hay antecedentes de serología VDRL positiva antes del embarazo, cuyo VDRL muestra títulos menores a 4 veces al VDRL anterior y hay evidencia de que su pareja o contacto(s) fue tratado
					Cuando el VDRL positivo corresponde a una serología control de una embarazada detectada el año anterior y las diluciones: a. se mantienen b. aumentan a menos de 4 veces de titulación inicial c. disminuyen a menos de 4 veces de titulación inicial
					Cuando exista evidencia en el expediente de la referencia a urgencias, II o III nivel de atención, por el antecedente de alergia a la penicilina benzatínica G o cuando la unidad no cuenta con las condiciones necesarias para la aplicación
Caso 3: CIE-10: R762 Falso positivo en la prueba serológica para sífilis	Positiva	Negativa	3	No aplicación de penicilina benzatínica G por vía intramuscular	Seguimiento según norma.
Caso 4: CIE-10: O981 Sífilis que complica el embarazo, parto y puerperio	Positiva	Positiva	4	Aplicación de penicilina G por vía intramuscular, según corresponda	Una dosis única de 2.4 millones de unidades de penicilina benzatínica G por vía intramuscular si la clasificación cronológica de la infección es: Sífilis primaria, secundaria o latente temprana
					Una dosis única de 2.4 millones de unidades de penicilina benzatínica G cuando la serología VDRL positiva corresponde a un control de una embarazada con diagnóstico de Sífilis Gestacional (primaria, secundaria o latente temprana), muestra un aumento igual o mayor a 4 veces la titulación anterior y se determina que se trata de una reinfección
					Una dosis de 2.4 millones de unidades de penicilina benzatínica G por semana por tres semanas si la clasificación cronológica de la infección es Sífilis latente tardía o latente de duración desconocida
					Una dosis de 2.4 millones de unidades de penicilina benzatínica G por semana por tres semanas cuando la serología VDRL positiva corresponde a un control de una embarazada con diagnóstico de Sífilis Gestacional (latente tardía o latente de duración desconocida), muestra un aumento igual o mayor a 4 veces la titulación anterior y se determina que se trata de una reinfección
					Una dosis de 2.4 millones de unidades de penicilina benzatínica G por semana por tres semanas cuando no se consigne en el expediente la clasificación cronológica de la infección
Caso 5: CIE-10: Z224 Portador de agentes de enfermedades infecciosas con un modo de transmisión predominantemente sexual			5	No aplicación de penicilina benzatínica G por vía intramuscular en los siguientes casos:	Cuando hay antecedentes de Sífilis tratada antes del embarazo, cuyo VDRL muestra títulos menores a 4 veces al VDRL anterior y hay evidencia de que su pareja o contacto(s) fue tratado
					Cuando el VDRL positivo corresponde a una serología control de una embarazada con Sífilis Gestacional detectada el año anterior y las diluciones: a. se mantienen b. aumentan a menos de 4 veces de titulación inicial c. disminuyen a menos de 4 veces de titulación inicial
					Cuando el VDRL positivo corresponde a una serología control de una embarazada con Sífilis Gestacional detectada el año anterior y las diluciones aumentan a más de 4 veces la titulación inicial y exista evidencia en el expediente de la referencia al II o III nivel de atención por fracaso terapéutico o neurosífilis
					Cuando existe evidencia en el expediente de la referencia a urgencias, II o III nivel de atención, por el antecedente en la embarazada de alergia a la penicilina benzatínica G o cuando la unidad no cuenta con las condiciones necesarias para la aplicación